Roteiro – Tópico 03

DIU de cobre como CE + aspectos clínicos e éticos da CE · Ginecologia – Prof.ª Laura Dias · 8 slides · tempo total ≈ **9–11 min**

Como usar este roteiro: a caixa azul é o que você fala (pode ler em voz alta nos ensaios até ficar natural — não precisa decorar palavra por palavra). A caixa rosa é a explicação do conteúdo, para você *entender* antes de apresentar. A caixa vermelha traz perguntas que podem cair.

Onde entra: logo depois do slide divisor "03 – DIU de cobre como CE + aspectos clínicos e éticos da CE" (que já está no Canva), antes do "04 – Laqueadura".
Siglas: CE = contracepção de emergência · LNG = levonorgestrel · UPA = acetato de ulipristal · DIU-Cu = DIU de cobre · IST = infecção sexualmente transmissível · PEP = profilaxia pós-exposição.

Abertura (slide divisor 03)

≈ 20 s

🎤 O QUE FALAR

"Meu colega mostrou as pílulas de emergência, que são hormonais. Agora eu vou falar da opção que muita gente esquece, mas que é a **mais eficaz de todas**: o DIU de cobre. E depois vamos ver o que muda na prática do consultório e quais são os cuidados éticos e legais quando uma paciente chega pedindo contracepção de emergência."

Slide 1 – DIU de cobre como CE

≈ 1 min 30 s

🎤 O QUE FALAR

"O DIU de cobre é esse pequeno 'T' de plástico com um fio de cobre enrolado na haste. O modelo mais usado é o TCu 380A, e ele é **oferecido pelo SUS**."

(aponte para a ilustração) "Como ele funciona? O cobre libera íons que provocam uma **reação inflamatória estéril** dentro do útero — não é infecção, é só um ambiente hostil. Esse ambiente é tóxico para os espermatozoides e para o óvulo, então eles perdem a função e **a fecundação não acontece**."

"Para servir como emergência, ele precisa ser inserido em até **5 dias, ou seja, 120 horas** depois da relação desprotegida. E a eficácia passa de **99%**: é a contracepção de emergência mais eficaz que existe."

(aponte para os 3 selos embaixo) “E tem três vantagens extras: ele não perde efeito em mulheres com IMC alto, não interage com remédios e — o melhor — a paciente já sai do consultório com um método que protege por até 10 anos.”

📚 **PARA ENTENDER (estude isto)**

- **Mecanismo principal:** efeito pré-fertilização (espermicida/ovocida). Como possível mecanismo secundário, se já tiver ocorrido fecundação, o cobre também dificulta a implantação — mas isso acontece *antes* da nidação, então não é aborto (aborto = interromper uma gestação já implantada).
- **Janela:** até 5 dias após a relação desprotegida — ou até 5 dias após a data provável da ovulação, se dá para estimá-la.
- **Eficácia:** taxa de gravidez ≈ 0,09% (menos de 1 em 1.000) — revisão sistemática de Cleland et al., 2012.
- **Duração:** o TCu 380A tem bula de 10 anos (a OMS considera seguro até 12).
- **Por que IMC não importa?** Porque o DIU age localmente, sem hormônio. Já o LNG, que é hormonal, perde eficácia em mulheres obesas.

❓ **SE A PROFESSORA PERGUNTAR**

- *“O DIU de cobre é abortivo?”* → Não. Ele age principalmente impedindo a fecundação, e qualquer efeito acontece antes da implantação. Não interrompe gravidez já estabelecida (e não se insere DIU em quem já está grávida).
- *“Por que ele não é a primeira escolha sempre?”* → Precisa de profissional treinado, de consulta e de exame especular. Nem toda paciente tem acesso rápido ou quer um DIU. A pílula é mais prática.

Slide 2 – A “Régua das 120 horas”

≈ 1 min 30 s

🎤 **O QUE FALAR**

“Para fixar, eu fiz essa ‘régua’: cada barra é um método, e o eixo é o tempo desde a relação, de 0 a 120 horas.”

“O **levonorgestrel** funciona melhor quanto antes for tomado — por isso a barra vai do verde ao vermelho. O ideal é até **72 horas**, aqui na linha vermelha. O **ulipristal** e o **DIU de cobre** mantêm a eficácia até o 5º dia.”

(aponte para a coluna da direita) “Olhem a diferença: com as pílulas, mais ou menos 1 a 2 em cada 100 mulheres ainda engravidam. Com o DIU, é menos de 1 em cada 1.000.”

(aponte para o exemplo) “Exemplo prático: a camisinha rompeu no sábado às 22h. O levonorgestrel deve ser tomado o quanto antes — o ideal é até terça às 22h. Mas, se ela só conseguir atendimento na quarta, ainda dá tempo de colocar o DIU até quinta às 22h.”

📚 **PARA ENTENDER (estude isto)**

- Conta das horas: 72 h = 3 dias; 120 h = 5 dias. Sábado 22h + 3 dias = terça 22h; + 5 dias = quinta 22h.
- Números aproximados de gravidez: **LNG ≈ 2,2%** e **UPA ≈ 1,4%** quando tomados em até 72 h (metanálise de Glasier et al., Lancet 2010); **DIU-Cu ≈ 0,09%**.
- O LNG pode ser usado até 120 h, mas a eficácia cai depois de 72 h. Por isso vale a frase: "quanto antes, melhor".
- O UPA é um modulador do receptor de progesterona, então ele consegue atrasar a ovulação até mais perto do pico de LH — por isso mantém a eficácia por mais tempo.

Slide 3 – Na prática: qual CE escolher?

≈ 1 min 30 s

🎤 **O QUE FALAR**

"Juntando tudo num fluxograma: a paciente chegou com relação desprotegida, ou falha do método, há até 5 dias. A primeira pergunta é: **ela quer um método de longa duração e não tem contraindicação ao DIU?** Se sim, o DIU de cobre é a primeira escolha, porque é o mais eficaz e já fica como método."

"Se não, vamos de pílula, e aí a pergunta é **há quanto tempo** foi a relação. Até 72 horas: levonorgestrel 1,5 mg em dose única, que é o que temos no SUS. Entre 72 e 120 horas: o ulipristal seria melhor, mas ele é pouco disponível no Brasil, então na prática usamos o levonorgestrel o quanto antes."

(aponte para o caso) "Vejam o caso da Júlia: 24 anos, camisinha rompeu há 4 dias, IMC 32 e ela diz que queria algo 'pra não se preocupar mais'. Três motivos apontam para o **DIU de cobre**: ela já passou das 72 horas, o IMC alto reduz o efeito do levonorgestrel e ela quer um método contínuo."

"E sempre lembrar: depois da pílula, a paciente precisa começar um método regular, junto com camisinha."

📚 **PARA ENTENDER (estude isto)**

- **IMC e LNG:** mulheres com IMC ≥ 30 (ou peso > 70–75 kg) têm mais falha com o LNG. Opções: DIU-Cu (melhor) ou UPA. Algumas diretrizes (FSRH) sugerem dose dobrada de LNG (3 mg) nesses casos — uso fora da bula.
- **Disponibilidade no Brasil:** o SUS oferece o LNG e o DIU de cobre. O ulipristal não é ofertado no SUS.

❓ **SE A PROFESSORA PERGUNTAR**

- *"E se ela tiver tomado indutor enzimático (carbamazepina, rifampicina...)?"* → O DIU de cobre é a melhor opção. Se for usar pílula, a recomendação é dobrar a dose do LNG (3 mg).

Slide 4 – DIU como CE: quando NÃO colocar?

≈ 1 min 15 s

🎤 **O QUE FALAR**

"O DIU tem algumas contraindicações. A principal é a **gravidez**, confirmada ou suspeita — por exemplo, se ela teve outra relação desprotegida semanas antes. Também não colocamos se houver **IST ou doença inflamatória pélvica ativa**, porque a inserção pode levar a infecção para dentro do útero. Outras: sangramento vaginal sem explicação, útero com a cavidade distorcida, câncer de colo ou de endométrio, doença trofoblástica, e alergia ao cobre ou doença de Wilson."

(lado direito) "E aqui vão alguns mitos: **nunca ter tido filhos não contraindica o DIU**, e adolescência também não. Ter usado CE antes e IMC alto também não atrapalham."

(caixa vermelha) "Um detalhe importante: em **violência sexual**, a norma técnica do Ministério da Saúde dá preferência ao levonorgestrel, por causa do risco de IST na hora de inserir o DIU."

📚 **PARA ENTENDER (estude isto)**

- Essas são as condições categoria 4 (não usar) dos **Critérios Médicos de Elegibilidade da OMS** para o DIU-Cu.
- **Doença de Wilson:** doença genética de acúmulo de cobre no organismo — por isso o DIU de cobre é contraindicado.
- **Nuliparidade e idade < 20 anos:** categoria 2 (pode usar; os benefícios superam os riscos). É um mito antigo que só mulher com filhos pode usar DIU.
- Na violência sexual, além da CE, entra o pacote de profilaxias: IST, HIV (PEP), hepatite B e vacinação.

Slide 5 – Aspectos clínicos da CE

≈ 1 min 30 s

🎤 **O QUE FALAR**

"Agora, seis pontos práticos que valem para qualquer CE."

"**Um:** sem burocracia. Para dar a pílula não precisa de exame físico nem de teste de gravidez — a história clínica basta."

"**Dois:** pode repetir? Pode, até no mesmo ciclo, é seguro. Mas não substitui um método regular, porque é menos eficaz e bagunça o ciclo."

"**Três:** depois do levonorgestrel, ela já pode começar ou retomar o anticoncepcional **no mesmo dia**, usando camisinha por 7 dias."

"**Quatro:** depois do ulipristal é diferente: precisa **esperar 5 dias** para começar o hormônio, porque o progestágeno 'anula' o efeito do ulipristal. Nesse período, usar camisinha."

"**Cinco:** a menstruação pode vir antes ou depois do esperado. Se atrasar **mais de 7 dias**, tem que fazer teste de gravidez."

"**Seis:** a CE **não protege contra IST**. Então, avaliamos o risco, orientamos a camisinha e, quando for indicado, fazemos a PEP."

📚 PARA ENTENDER (estude isto)

- **Por que não precisa de teste?** A CE não faz mal a uma gestação já existente; ela só não vai funcionar. O teste atrasaria o atendimento, e o tempo é crucial.
- **Quick start** é o nome de começar o método regular logo após a CE, sem esperar a menstruação.
- **Interação UPA × progestágeno:** o UPA bloqueia o receptor de progesterona, e um progestágeno logo depois compete com ele e reduz o efeito. Por isso a espera de 5 dias (FSRH, OMS).
- O vômito em até 3 h já foi falado pelo colega (repete a dose).

Slide 6 – Aspectos éticos e legais

≈ 2 min

🎤 O QUE FALAR

"Por fim, os aspectos éticos e legais — que caem muito em prova."

"**Autonomia:** o artigo 42 do Código de Ética Médica proíbe o médico de desrespeitar o direito da paciente de decidir livremente sobre o método contraceptivo. E ele tem o dever de explicar riscos e benefícios. Isso conversa com a Lei do Planejamento Familiar, a 9.263 de 96."

"**Adolescentes:** elas têm direito a atendimento e sigilo, e **não é obrigatório** estar com os pais. A exceção é a menor de 14 anos: pelo Código Penal, relação sexual nessa idade é considerada **estupro de vulnerável**. Então precisamos notificar e acionar o Conselho Tutelar."

"**Violência sexual:** pela Lei 12.845, conhecida como Lei do Minuto Seguinte, o atendimento é imediato e integral, e inclui a prevenção da gravidez. **Não precisa de boletim de ocorrência.** E a notificação é compulsória."

"**Objeção de consciência:** o médico pode se recusar a fazer algo que vá contra a sua consciência, mas tem que **garantir que a paciente seja encaminhada**. E não pode recusar em situação de urgência ou quando não houver outro profissional. E vale lembrar: **contracepção de emergência não é aborto**."

📚 PARA ENTENDER (estude isto)

- **CEM art. 42:** "É vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, reversibilidade e risco de cada método."
- **CEM art. 74:** proíbe revelar segredo sobre paciente menor de idade, inclusive aos pais, desde que ele tenha capacidade de discernimento — salvo quando a não revelação puder trazer dano a ele.

- **Código Penal art. 217-A:** estupro de vulnerável = conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos.
- **Lei 12.845/2013:** atendimento obrigatório, emergencial e integral às vítimas de violência sexual no SUS. Inclui a profilaxia da gravidez e de ISTs. A palavra da vítima basta; não precisa de B.O.
- **Lei 10.778/2003:** notificação compulsória da violência contra a mulher atendida nos serviços de saúde.
- **Objeção de consciência:** Código de Ética Médica, cap. I, inciso VII, e cap. II, inciso IX. O médico pode recusar, "salvo na ausência de outro médico, em casos de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente".

❓ **SE A PROFESSORA PERGUNTAR**

- *"Adolescente de 15 anos pede CE sozinha. Pode prescrever?"* → Pode. Ela tem direito a atendimento e sigilo. Orienta, prescreve e oferece um método regular.
- *"E se fosse uma menina de 13 anos?"* → Pode e deve prescrever a CE, mas é estupro de vulnerável: notificar e acionar o Conselho Tutelar.

Slides 7 e 8 – Mito ou Verdade?

≈ 1 min 30 s

🎤 **O QUE FALAR**

"Para fechar, um jogo rápido: eu leio a frase e vocês levantam a mão se acharem que é **mito**." *(leia as 6 frases do slide 7, uma por vez, e espere 2–3 segundos em cada)*

(passe para o slide 8) "Vamos às respostas: 1 é mito — não ter filhos não contraindica o DIU. 2 é verdade — o DIU de cobre é a CE mais eficaz. 3 é mito — a adolescente tem direito a atendimento e sigilo. 4 é mito — pela Lei do Minuto Seguinte, não precisa de B.O. 5 é mito — CE só previne gravidez; para IST, preservativo e PEP. E 6 é verdade — o DIU colocado como emergência pode ficar como método por até 10 anos."

"Com isso eu encerro a parte de contracepção de emergência. Agora o [nome do colega] vai começar os métodos irreversíveis, com a laqueadura."

Cola: números para decorar

O quê	Número
Janela do DIU de cobre como CE	**até 5 dias (120 h)**
Eficácia do DIU-Cu como CE	**> 99%** (gravidez ≈ 0,09%)
Duração do TCu 380A	**10 anos**
LNG – dose / janela ideal	**1,5 mg dose única** / até **72 h** (pode até 120 h, com eficácia menor)
UPA – dose / janela	**30 mg** / até **120 h**
IMC que reduz a eficácia do LNG	**≥ 30**
Após UPA, esperar para iniciar hormônio	**5 dias**
Atraso menstrual → teste de gravidez	**> 7 dias**
Estupro de vulnerável	**< 14 anos** (CP art. 217-A)
Leis	CEM **art. 42** (autonomia) · CEM **art. 74** (sigilo do menor) · **Lei 12.845/13** (violência sexual, sem B.O.) · **Lei 9.263/96** (planejamento familiar)

Dicas de apresentação

- Aponte sempre para a ilustração ou o gráfico enquanto fala: os slides foram feitos para isso, e você não precisa ler os bullets.
- Nos slides de cards (5 e 6), fale só o título e uma frase de cada card. Os detalhes já estão escritos no slide.
- Ensaie com cronômetro duas vezes. Se passar de 11 min, corte o caso da Júlia e fale só o fluxograma.
- Frase-resumo, se der branco: *"O DIU de cobre é a CE mais eficaz, funciona até 5 dias e já vira método; a CE é direito da paciente, inclusive da adolescente e da vítima de violência, sem precisar de B.O."*

Referências: OMS – Emergency contraception (fact sheet/guideline, 2021) e Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use (5ª ed., 2015); Cleland K. et al. Hum Reprod 2012;27(7):1994-2000; Glasier AF et al. Lancet 2010;375:555-62; FSRH Clinical Guideline: Emergency Contraception (2017, atualizada 2023); FEBRASGO – Manual de Anticoncepção (2015); Ministério da Saúde – Norma Técnica "Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes" (3ª ed., 2012); Código de Ética Médica (Res. CFM 2.217/2018); Lei 12.845/2013; Lei 10.778/2003; Lei 9.263/1996; Código Penal, art. 217-A.